

12 자궁암(Uterine Cancer)

투여대상은 조직학적으로 선암(adenocarcinoma), 암육종(carcinosarcoma)인 자궁내막암(endometrial cancer)임

※ 자궁육종(uterine sarcoma)의 경우 연조직육종의 치료에 준함 (leiomyosarcoma, stromal sarcoma)

1. 수술후보조요법(adjuvant)

연번	항암요법	투여대상
1	paclitaxel + carboplatin (제2019-31호: 2019.2.13, 개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	가. 수술 후 조직학적으로 확인된 stage III,IV 진행성 자궁내막암 (투여기간: 최대 9주기) 나. stage I, II 유두상 장액성(papillary serous) 또는 투명세포(clear cell) 자궁내막암 (투여기간: 6주기)

2. 고식적요법(palliative)

가. 투여단계: 1차(first line)

연번	항암요법	투여대상
1	dostarlimab ^{주1} + paclitaxel + carboplatin (제2025-210호: 2025.10.1.)	진행성(FIGO stage III이상) 또는 재발성 자궁내막암으로 다음을 모두 만족하는 경우 ① dMMR(mismatch repair deficient)/MSI-H(microsatellite instability-high)인 자궁내막암 ② 진행성 자궁내막암 중 FIGO Stage IIIA - IIIC1의 경우는 평가 혹은 측정 가능한 병변이 존재 (단, 병기 IIIC1 진행성 암육종, 장액성, 투명세포, 혼합형(암육종, 장액성, 투명세포 ≥10% 이상), 또는 병기 IIIC2 - IV 자궁내막암의 경우는 평가 혹은 측정 가능한 병변 유무 상관 없음) ※ 선행화학요법/수술후보조요법 치료 종료 후 6개월 이후 재발한 경우 포함 ※ 이전 PD-1 inhibitor, PD-L1 inhibitor, PD-L2 inhibitor 치료를 받지 않은 경우에 한함

나. 투여단계: 1차 이상

연번	항암요법	투여대상
1	doxorubicin (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	자궁내막암
2	doxorubicin + cisplatin (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	
3	doxorubicin + carboplatin (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	
4	doxorubicin + carboplatin + cyclophosphamide (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	
5	doxorubicin + cisplatin + cyclophosphamide (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	
6	cisplatin (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	
7	fluorouracil + cisplatin (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	
8	carboplatin (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	
9	tamoxifen (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	
10	progesterone (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	
11	ifosfamide + cisplatin (개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	
12	paclitaxel + carboplatin (제2017-75호: 2017.4.1, 개정 제2022-190호: 2022.8.1.)	전이성 또는 재발성 자궁내막암

다. 투여단계: 2차

연번	항암요법	투여대상
1	pembrolizumab ^{주1} + lenvatinib (제2025-272호: 2026.1.1.)	이전의 백금기반 화학요법 이후 진행이 확인되고* 수술적 치료 또는 방사선 치료가 부적합한 진행성 자궁내막암으로 다음을 모두 만족하는 경우 ① dMMR(mismatch repair deficient) 또는 MSI-H(microsatellite instability- high)가 없는 자궁내막암 ② ECOG 수행능력 평가(PS: Performance Status)가 0 또는 1 * 수술후보조요법으로 백금기반 항암요법 치료를 받고 1년 이내에 재발한 경우도 포함. ※ 이전 PD-1 inhibitor, PD-L1 inhibitor, PD-L2 inhibitor, VEGF inhibitor 치료를 받지 않은 경우에 한함 ※ 암육종(carcinosarcoma)은 투여대상에서 제외함

라. 투여단계: 2차 이상

연번	항암요법	투여대상
1	dostarlimab ^{주1} (제2023-279호:2023.12.1.,)	백금기반 화학요법 치료 중 또는 치료 후 진행된 재발성 또는 진행성 (FIGO stage IIIB 이상) 자궁내막암으로 다음을 모두 만족하는 경우 ① dMMR(mismatch repair deficient)/MSI-H(microsatellite instability-high)인 자궁내막암 ② ECOG 수행능력 평가(PS: Performance Status)가 0 또는 1 ※ 이전 PD-1 inhibitor, PD-L1 inhibitor, PD-L2 inhibitor 치료를 받지 않은 경우에 한함 ※ 암육종(carcinosarcoma)은 투여대상에서 제외함
2	pembrolizumab ^{주1} (제2025-272호: 2026.1.1.,)	백금기반 화학요법 치료 중 또는 치료 후 진행된* 재발성 또는 진행성 자궁내막암으로 다음을 모두 만족하는 경우 ① dMMR(mismatch repair deficient) 또는 MSI-H(microsatellite instability-high)인 자궁내막암 ② ECOG 수행능력 평가(PS: Performance Status)가 0 또는 1 * 수술후보조요법으로 백금기반 항암요법 치료를 받고 1년 이내에 재발한 경우도 포함. ※ 이전 PD-1 inhibitor 등 면역관문억제제 치료를 받지 않은 경우에 한함 ※ 암육종(carcinosarcoma)은 투여대상에서 제외함

주1. 면역관문억제제(nivolumab, pembrolizumab 등)는 예상치 못한 부작용 발생 등의 긴급 상황에 대응 가능한 의료기관에서 항암치료요법에 대한 지식과 경험이 충분한 의사에 의해 투여되어야 하며, 요양급여 실시 현황 등에 관한 자료를 건강보험심사평가원장에게 제출하여야 한다.

- 급여인정기관: 다음의 한 가지 이상에 해당하는 기관 중 상근하는 혈액종양내과, 감염 또는 내분비내과, 병리와 전문의가 각 1인 이상인 기관

〈 다 음 〉

- ① ‘응급의료에 관한 법률’에 따른 지역응급센터 이상의 기관
- ② ‘암관리법’에 따른 암센터
- ③ ‘방사선 및 방사성 동위원소 이용진흥법’에 따라 설립된 한국원자력의학원의 사업에 의한 요양기관

- 급여인정기간: 1년까지(단, 질병진행시 중단) 급여인정 하되, 1년 내에 최적의 투여기간에 대한 임상결과 미 발표 시 자동 연장하여 최대 2년으로 함.
- 투여대상: PD-L1 발현율 등의 biomarker를 활용하여 투여대상을 선정하되, 세부 암종별 특성에 따라 달리 적용할 수 있음.
- 사후관리: 요양기관에서 제출한 급여실시내역을 활용하여 효과 및 부작용에 대한 모니터링을 실시할 수 있음.